

Control de soportes reales pendientes del estándar Interdependencia y remisión

Objetivo

Establecer una secuencia verificable para control de soportes reales pendientes del estándar interdependencia y remisión, articulada con la oferta y los recursos reales del consultorio.

Alcance y responsabilidades

Aplicación en psicología ambulatoria, dentro de competencia y modalidad habilitada. Responsable clínico o del proceso: asignar en la adopción; personal de apoyo actúa según rol y entrenamiento. Confirmar aplicabilidad al prestador y sede antes de adoptar.

Términos de uso

Criterio: condición que se verifica. Evidencia: soporte auténtico de lo realizado. No conformidad: diferencia frente al criterio aplicable. Contención: medida inmediata para impedir daño. Cierre: corrección cuya eficacia se comprobó. Los términos clínicos/técnicos particulares se interpretan conforme a la guía o manual indicado.

Objeto

Identificar qué soporte auténtico exige el estándar según sede, oferta y tipo de prestador. El estado permanece pendiente hasta verificar evidencia, no simplemente imprimir este documento.

Evidencias a incorporar

1. Verificar exigencia del servicio/modalidad concreta. No presumir convenio de ambulancia universal.
2. Directorio verificado, motivo/prioridad, receptor, transporte apropiado y comunicación mínima.
3. Verificar permisos/competencia de laboratorios, radiología y reprocesamiento si se usan.
4. Confirmar entrega, acceso, recomendaciones y resultados pendientes con responsable.

Revisión

Confirmar origen, fecha, vigencia, alcance y acceso reservado del soporte. Justificar no aplicabilidad y registrar brechas; no emitir certificados ni crear acuerdos inexistentes.

Aplicación paso a paso y respuesta a desviaciones

Preparación de la red

Verificar contactos, horarios y requisitos reales de urgencias, medicina, psiquiatría y protección infantil/violencias. La carpeta no presume convenio obligatorio con todos los servicios del checklist; justificar según criterio, oferta y territorio.

Entrega

Definir motivo, prioridad, datos mínimos y autorización/causal legal. Contactar receptor y confirmar ruta; en peligro inmediato activar urgencias sin esperar trámite administrativo.

Continuidad

Comprobar acceso y respuesta, barreras y recomendaciones. Mantener control de resultados pendientes y responsable del siguiente contacto. Documentar retorno o transferencia sin abandonar el caso por haber emitido un formato.

Auditoría

Revisar oportunidad, recepción y cierre en una muestra codificada. Registrar incidentes de comunicación y alternativa cuando el apoyo no está disponible; actualizar directorio después de cada cambio identificado.

Frecuencia y puntos de control

Ejecutar en cada atención, tarea o cambio que active este proceso. Definir periodicidad de revisión por riesgo, oferta, fabricante y norma aplicable; registrar la programación local. La periodicidad local no se presenta como exigencia legal universal.

Registros relacionados

Usar los formatos individuales vinculados al código PSI-AN7 en el índice maestro. Asociar fecha, responsable, resultado y ubicación de evidencia. Las historias y consentimientos diligenciados se mantienen en expediente reservado; los soportes administrativos no deben exponer datos clínicos.

Verificación, fundamento y adopción

Indicador y método de evaluación

Indicador local propuesto: ejecuciones verificadas con pasos críticos completos / ejecuciones revisadas $\times 100$. Definir periodo, muestra, fuente y meta según riesgo. Con denominador cero anotar no calculable. Registrar además oportunidad y gravedad de desviaciones; no interpretar ausencia de reporte como ausencia de daño.

Acciones correctivas

Describir hallazgo concreto, medida inmediata, causa, acción, responsable y plazo. Verificar eficacia con evidencia posterior antes de cerrar. Si existe riesgo activo o falta competencia/recurso, suspender la actividad afectada y coordinar alternativa segura.

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes. Criterios generales 11.1 y consulta externa 11.2.1; 11.2.2 para oferta especializada que corresponda. La Resolución 2080 de 2026 revocó la 1732 de 2026; no se aplica su manual como régimen vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Psicología

Ley 1090 de 2006, ética, competencia, reserva, pruebas y consentimiento. Ley 1616 de 2013 modificada por Ley 2460 de 2025: marco de salud mental con enfoques de derechos y diferencial.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=66205>

Fuentes técnicas particulares

Consultar versión íntegra y vigente, población y metodología; adaptar con trazabilidad. Una referencia técnica orienta práctica y no es legislación colombiana.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Soportes auténticos que deben anexarse

Adjuntar documentos de autoridad, títulos/licencias, guías completas, instrucciones del fabricante, contratos o registros reales que correspondan al contenido. No se producen certificados, mantenimientos, planos técnicos ni evidencias de ejecución ficticias.

Adopción y actualización

Completar responsables, recursos, límites y registros; aprobar con autenticación válida y capacitar antes de utilizar. Revisar ante cambio normativo, incidente, tecnología o población. El encabezado permanece vacío para personalización; el contenido es propuesta y no acredita por sí mismo cumplimiento.

Aprobó

Natalia Angel Usuga